TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OURINHOS
FORO DE OURINHOS
3ª VARA CÍVEL
RUA EXPEDICIONÁRIO, 1895, Ourinhos - SP - CEP 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1005602-55.2024.8.26.0408**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos**
Requerente:	**Marilia Gabriela Bunholo Siqueira**
Requerido:	**BRADESCO SAÚDE S/A**

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Flavio Augusto Reinert de Freitas**

Vistos.

MARÍLIA GABRIELA BUNHOLO SIQUEIRA ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC TUTELA DE URGÊNCIA** em face de **BRADESCO SAÚDE S/A**. Narra a autora que é segurada do plano empresarial denominado Saúde Top, ofertado pela ré. Em exame de mamografia, teve diagnosticado câncer de mama, razão pela qual foi-lhe prescrito "carboplatina + paclitaxel semanal durante 12 ciclos associados ao pembrolizumabe a cada 03 semanas. Seguido de doxorrubicina + ciclofosfamida a cada duas semanas durante 04 ciclos associado ao pembrolizumabe a cada 03 semanas". No dia 23.07.2024, enviou à ré a prescrição com solicitação de disponibilização, mas no dia 24.07.2024, a ré negou a dispensação da medicação ao fundamento de que tinha caráter experimental. Em sede de tutela de urgência, pede seja a ré compelida a dispensar imediatamente o tratamento prescrito, confirmando-se, ao final, com a consequente procedência do pedido (fls. 01/07). Junta documentos (fls. 08/181).

Deferida a tutela de urgência (fls. 183/189), a ré foi citada e ofertou contestação.

Na contestação, a ré informa que a apólice da autora é posterior a Lei nº 9.656/98, estando, portando, vinculada ao Rol da ANS. Diz que o diagnóstica atesta que a autora é portadora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

de câncer de mama RE(+) RP (-) HER2(-), que teve indicado o tratamento com o medicamento Keytruda 200 mg ev – ciclo I, associado com o medicamento Fauldcarbo 210 mg, os quais não têm prescrição recomendada para tal patologia, conforme atestam suas respectivas bulas. Assim, porque a indicação clínica não esta contemplada na bula anvisa, a dispensação dos medicamentos foi negada. Assevera que a prescrição de medicamento em desconformidade com as patologias e situações indicadas na bula caracteriza tratamento experimental (*off label*), o qual, por força da apólice firmada entre as partes, não está obrigada a fornecer. Pede a improcedência dos pedidos (fls. 209/222). Junta documentos (fls. 223/462).

A autora se manifestou em réplica (fls. 470/480), oportunidade em que juntou novos documentos (fls. 481/685).

Na sequência, manifestou-se a ré sobre os novos documentos apresentados pela autora (fls. 689/691).

Instadas a especificarem provas (fl. 692), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 695/696 e 697/699).

É o relatório.

FUNDAMENTO e **DECIDO**.

Inexistem matérias pendentes de análise.

Partes legítimas e regularmente representadas, estão presentes todas as condições da ação e pressupostos processuais, razões pelas quais passo direto ao conhecimento do mérito.

No mérito, os pedidos são **procedentes**.

Ao fundamento de que foi diagnóstica como portadora de câncer de mama (CID 10 C50), a autora visa compelir a ré a dispensar-lhe o seguinte tratamento:

> "Proposta de carboplatina + paclitaxel semanal durante 12 ciclos associados ao pembrolizumabe a cada 03 semanas. Seguido de doxorrubicina + ciclofosfamida a cada duas semanas durante 4 ciclos associado ao pembrolizumabe a cada 3 semanas." (fl. 22)

A requerida, por sua vez, nega o pleito sustentando que a prescrição medicamentosa está em desconformidade com as situações indicadas nas respectivas bulas, o que caracteriza tratamento experimental (off-label), o qual, por força de disposição contratual, não está

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

obrigada a fornecer.

Pois bem.

De antemão, ressalto que a relação jurídica que vincula as partes litigantes é de consumo, de modo que a interpretação deve ser feita segundo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), assumindo a requerida a posição de fornecedora de produtos e serviços e, a requerente, de consumidora final desses bens, numa típica relação consumerista.

E quanto à plena submissão da exegese desse contrato às normas protetivas do mencionado Código de Defesa do Consumidor, em relação ao qual é posterior, é entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula nº 469).

Deste modo, interpretadas as cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o disposto no artigo 51, inciso IV, do diploma consumerista:

> "Artigo 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
>
> (...)
>
> IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade".

Transcrevo, também, o teor do § 1º, incisos I, II e III, do mesmo artigo:

> "§ 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
>
> I - ofende os princípios fundamentais o sistema jurídico a que pertence;
>
> II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
>
> III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Cumpre salientar, ainda, que a saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal de 1988 à condição de direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

fundamental, de modo que não pode ser caracterizada como simples mercadoria, nem confundida com outras atividades econômicas.

Assim, o particular que presta uma atividade econômica correlacionada com serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado à luz do contratado, ou seja, prestar assistência médica integral aos consumidores dos seus serviços negociados.

No caso dos autos, não se controverte o diagnóstico da autora; a sua qualidade de segurada; tampouco que lhe assiste direito a dispensação de medicamento antineoplásico oral (e correlatos); ou que a medicação prescrita não teria registro junto a ANVISA.

A resistência da ré se dá única e exclusivamente sob a tese de o tratamento prescrito seria experimental. Ela ampara suas alegações na Resolução Normativa ANS nº 465/2021, que acerca do tema dispõe:

> "Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
>
> Parágrafo único. **São permitidas as seguintes exclusões assistenciais**:
>
> I - **tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que**:
>
> a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;
>
> b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou
>
> c) **faz uso off-label de medicamentos**, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24;

Segundo alega, "a segurada apresenta diagnóstico de câncer de mama RE(+) RP(-) HER2(-) e sua indicação não está de acordo com as bulas da ANVISA do tratamento com os medicamentos KEYTRUDA (pembrolizumabe) + FAUDCARBO (carboplatina)". Em razão disso, o tratamento foi negado.

Analisando a bula do pembrolizumabe, vê-se que ele é indicado para tratamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

antineoplásico (fl. 212):

> • Câncer de mama triplo-negativo
> KEYTRUDA®, em combinação com quimioterapia, é indicado para tratamento de pacientes adultos com câncer de mama triplo negativo (TNBC) localmente recorrente irressecável ou metastático, cujos tumores expressam PD-L1 com PPC ≥ 10, conforme determinado por exame validado, e que não receberam quimioterapia prévia para doença metastática.
>
> KEYTRUDA® é indicado para o tratamento neoadjuvante de pacientes com câncer de mama triplo negativo (TNBC) de alto risco em estágio inicial em combinação com quimioterapia, e continuado como monoterapia no tratamento adjuvante após a cirurgia.

De igual modo, atesta a bula do carboplatina (fl. 212):

> **1. INDICAÇÕES**
> A carboplatina, princípio ativo de **Fauldcarbo®** solução injetável, faz parte da segunda geração de derivados da cisplatina que mostram atividade antineoplásica contra uma série de malignidades.
> **Fauldcarbo®** solução injetável está indicado no tratamento de estados avançados do carcinoma de ovário de origem epitelial (incluindo tratamentos de segunda linha e paliativo em pacientes que já tenham recebido medicamentos contendo cisplatina). Está também indicado no tratamento do carcinoma de pequenas células de pulmão, nos carcinomas espinocelulares de cabeça e pescoço e nos carcinomas de cérvice uterina.

Assim, ambos os medicamentos têm indicação para tratamento antineoplásico, donde se vê que o fundamento apresentado pela ré é abusivo.

Não bastasse, observa-se que, antes da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, vigia a Resolução Normativa nº 338/2013, a qual dispunha praticamente a mesma coisa, confira:

> "Art. 19. § 1º **São permitidas as seguintes exclusões assistenciais previstas no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998**:
>
> I - **tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que**:
>
> a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;
>
> b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina - CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia- CFO; ou
>
> c) **não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)**."

Analisando essas disposições, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.769.557 CE (2018/0255560-0), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pontou o seguinte:

> "A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente.
>
> Desse modo, ao estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

tratamento clínico ou cirúrgico que "não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)", a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora.

Em outras palavras, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico.

Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo.

Note-se que a conduta da operadora, supostamente justificada por referida resolução normativa da ANS, chega ao absurdo de envolver os limites de interpretação da bula diante de uma situação concreta."

Assim, com base nesse raciocínio, aquela Corte julgou o caso nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. **NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE**. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1º/10/18. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

procedimentos da ANS. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 8. **O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.** 9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes. 11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp n. 1.769.557/CE; Terceira Turma; Relatora Ministra Nancy Andrighi; julgado em 13.11.2018 – destaquei)

Não obstante as constantes atualizações normativas e, consequentemente, jurídicas, acerca do tema, observa-se que persistem as teses de que "**quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico" e que "**Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo**", bem como a tese de que **"O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica."**

Nesse sentido, os seguintes julgados junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça:

> "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. REMÉDIO. CUSTEIO. LIMITES DA ÁREA DE ATUAÇÃO GEOGRÁFICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. DISCUSSÃO DA NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 1.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 1.2. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 1.3. A Corte de apelação concluiu que a parte agravada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

não recebeu atendimento médico fora dos limites da área de atuação da agravante. Devido à necessidade de novamente interpretar cláusulas contratuais e analisar o acervo probatório da demanda, não há como averiguar, em recurso especial, se a empresa agravante teria sido condenada ao custeio do medicamento descrito na inicial além da área de atuação geográfica prevista no contrato do plano de saúde. 2. "Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt no REsp n. 2.036.691/MG, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023), o que foi observado na origem. 3.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.043.178/SP; Quarta Turma; Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira; julgado em 11.12.2023 – grifei)

E ainda:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. DISCUSSÃO DA NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt no REsp n. 2.036.691/MG, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 3. Para a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023), o que foi observado na origem. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Sobre o pedido de exclusão dos danos morais, impõe-se ressaltar que "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5ª Região -, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018). 6. Em relação ao requerimento de revisão do valor dos danos morais, a falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.080.866/SP; Quarta Turma; Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira; julgado em 09.10.2023 – grifei)

Portanto, estando consolidado esse entendimento há mais de cinco anos, percebe-se que o fundamento invocado pela ré para recusar a dispensação do tratamento prescrito à autora, além de abusivo, é indevido.

Por sua vez, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não destoa. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de assistência à saúde – Tutela antecipada

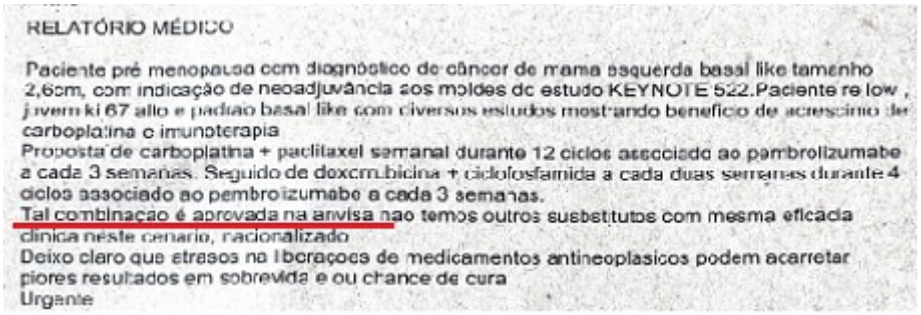
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

> – Autora diagnosticada com "neoplasia mesenquimal com rearranjo no gene GLI-1 no quadril esquerdo, com metástases na parede torácica esquerda e coxa direita" – Determinação de fornecimento do medicamento "Votrient (cloridrato de pazopanib)", no prazo de 7 dias, sob pena de multa diária – Insurgência da ré/operadora – Alegação de que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela – **Prescrição "fora da bula" - Descabimento – Obrigatoriedade do fornecimento de medicamento antineoplásico, mesmo que prescrito "fora da bula" – Precedente do STJ** – Presentes os requisitos do artigo 300, do CPC – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO." (Agravo de Instrumento 2027795-73.2025.8.26.0000; 7ª Câmara de Direito Privado; Relator Desembargador Miguel Brandi; julgado em 12.03.2025 – destaquei)

Como visto, a ré resistiu a pretensão da autora apenas ao fundamento de que a prescrição dos medicamentos pembrolizumabe e carboplatina está em desconformidade com a bula. Não apresentando, portanto, qualquer justificativa para a recusa no fornecimento dos medicamentos paclitaxel, ciclofosfamida e doxorrubicina.

Apesar de a decisão de fls. 183/189 ter dispensado a ré de fornecer os medicamentos doxorrubicina e paclitaxel por não apresentarem, na ocasião, registro ativo perante a ANVISA, verifica-se que, em nenhum momento a ré argumentou sobre eventual falta de registro.

Por sua vez, a prescrição médica deixa claro que os medicamentos prescritos contam com registro perante a ANVISA. Confira (fl. 22):


RELATÓRIO MÉDICO

Paciente pré menopausa com diagnóstico de câncer de mama esquerda basal like tamanho 2,6cm, com indicação de neoadjuvância aos moldes do estudo KEYNOTE 522.Paciente re low , jovem ki 67 alto e padrão basal like com diversos estudos mostrando benefício de acréscimo de carboplatina e imunoterapia
Proposta de carboplatina + paclitaxel semanal durante 12 ciclos associado ao pembrolizumabe a cada 3 semanas. Seguido de doxorrubicina + ciclofosfamida a cada duas semanas durante 4 ciclos associado ao pembrolizumabe a cada 3 semanas.
Tal combinação é aprovada na anvisa não temos outros susbstitutos com mesma eficácia clínica neste cenário, racionalizado
Deixo claro que atrasos na liberações de medicamentos antineoplásicos podem acarretar piores resultados em sobrevida e ou chance de cura
Urgente

Ainda, verifica-se que a própria autora informa que, desde o deferimento da tutela de urgência, a ré tem disponibilizado todos os medicamentos, inclusive aqueles que não ficou obrigada a dispensar (fl. 698).

Por fim, em nova consulta à ANVISA nesta oportunidade, constata-se que,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OURINHOS
FORO DE OURINHOS
3ª VARA CÍVEL
RUA EXPEDICIONÁRIO, 1895, Ourinhos - SP - CEP 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

atualmente, o medicamento paclitaxel apresenta registro. No destaque:

Consultas
ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Resultado da Consulta de Produtos

	Nome do Produto	Complemento da Marca	Tipo de Regularização	Princípio Ativo ou Descrição do Medicamento Notificado	Número da Regularização	Número do Processo	Empresa Detentora da Regularização	Situação da Regularização	Vencimento da Regularização
☐	ONTAX		REGISTRADO	PACLITAXEL	100330115	25000.022166/9425	LIBBS FARMACÊUTICA LTDA - 61.230.314/0001-75	Ativo	09/2028
☐	ONXEL		REGISTRADO	PACLITAXEL	101620232	25000.009791/9950	LABORATÓRIOS	[illegible]	06/2017

Quanto ao doxorrubicina, apesar de não lograr êxito em localizar qualquer medicamento registrado sob esta exata nomenclatura, vê-se que o sistema apresenta a opção também sob a nomeclatura cloridrato de doxorrubicina, que, por sua vez, ostenta vários registros ativos.

Consultas
ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Resultado da Consulta de Produtos

	Nome do Produto	Complemento da Marca	Tipo de Regularização	Princípio Ativo ou Descrição do Medicamento Notificado	Número da Regularização	Número do Processo	Empresa Detentora da Regularização	Situação da Regularização	Vencimento da Regularização
☐	DOCKS		REGISTRADO	CLORIDRATO DE DOXORRUBICINA	155370067	25351.405065/2018-26	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA - 64.171.697/0001-46	Ativo	10/2028

Assim, considerando que a ré nada argumenta sobre eventual ausência de registro da medicação prescrita e considerando que o relatório médico da autora atesta que a prescrição tem registro na ANVISA, é o caso de se acolher integralmente a pretensão da autora.

Portanto, é de rigor a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos para, rerratificando a tutela de urgência deferida às fls. 183/189, **CONDENAR** a ré a dispensar à autora toda a prescrição médica contida no relatório de fl. 22, cujo cumprimento já está em andamento, conforme noticiado à fl. 698.

Por conseguinte, **EXTINGO** o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OURINHOS
FORO DE OURINHOS
3ª VARA CÍVEL
RUA EXPEDICIONÁRIO, 1895, Ourinhos - SP - CEP 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se e intimem-se.

Ourinhos, 08 de maio de 2025.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIO AUGUSTO REINERT DE FREITAS, liberado nos autos em 08/05/2025 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005602-55.2024.8.26.0408 e código bAchnVf2.